

便秘係指大便次數少、質地硬，或者難以排出。呢個情況好常見 — 而且對盆腔健康有影響，因為用力排便會令脫垂、漏尿同盆腔痛惡化。好消息係，大部分便秘靠一啲簡單嘅方法就可以改善。

關於呢個病

正常大便應該唔需要用力就可以排出。便秘嘅徵狀包括：每週大便少於三次、大便硬或者有顆粒、需要用力排便、感覺排唔清（殘餘感），或者需要用手壓住陰道或肛門附近先至排到大便（「扶托法」）。

成因

- **纖維素同飲水不足**，加上缺乏活動
- **忍便**，唔聽從身體嘅排便訊號
- **藥物** — 鴉片類止痛藥、鐵劑等
- **盆底肌肉問題** — 肌肉唔放鬆，令大便排唔出（「出口型」便秘）
- 大腸蠕動緩慢

「出口型」便秘需要**盆底物理治療**，唔係單靠瀉藥。

詞彙解釋

便秘

大便次數少、質地硬或難以排出。

纖維素

植物成分，可以令大便軟化同增加體積。

滲透性瀉藥

溫和通便藥（如 PEG），靠吸水令大便軟化。

出口型便秘

因盆底肌肉唔放鬆而難以排便。

生物反饋治療

訓練肌肉放鬆以完成排便嘅治療。

扶托法

用手壓住陰道或肛門附近幫助排便。

點解泌尿科醫生會關心便秘？ 因為用力排硬便會對支撐膀胱同盆腔器官嘅結構施壓 — 所以便秘會令脫垂同漏尿惡化，而且直腸充脹亦會壓迫膀胱。改善便秘往往同時改善膀胱症狀。

點樣治療（逐步進行）

- 1 **纖維素、飲水同活動** — 逐漸增加纖維素攝入（食物或補充劑），並配合充足飲水。
- 2 **排便習慣** — 有便意時即刻去廁所，用腳踏墊高膝蓋（模擬蹲姿），唔好用力迫。
- 3 **溫和瀉藥** — 滲透性瀉藥（如 PEG）如有需要可定期使用，係安全嘅。
- 4 **盆底物理治療／生物反饋**用於出口型便秘；同時同醫療團隊檢討有否致便秘嘅藥物。

健康排便習慣

- 盡量**每日同一時間**排便，通常係飯後。
- 唔好趕，比自己足夠時間；切勿用力迫。
- 保持活動 — 每日散步都有助腸道蠕動。

實用貼士

- 纖維素要**慢慢增加**，避免脹氣，同時要飲足夠水。
- 刺激性瀉藥偶爾使用可以；如需每日用，請先問醫生。
- 如果主要問題係用力排便，多數係肌肉協調問題 — 物理治療比增加瀉藥更有效。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- **大便有血**，或無原因體重下降
- 新出現且唔改善嘅便秘，尤其年長人士
- 嚴重肚痛、嘔吐，或**完全唔排氣排便**（可能係腸塞）

要記住嘅三件事

1. 便秘好常見，且影響盆腔健康 — 用力排便會令脫垂同漏尿惡化。
2. 靠纖維素、飲水、活動、良好排便習慣（腳踏、唔用力迫）及適時使用溫和瀉藥來改善。
3. 如持續需要用力排便，問醫生關於盆底物理治療。大便有血、體重下降或突然出現嚴重變化要即刻匯報。